

CASO DE ESTUDIO: "EL SILENCIO DE MARIANA"

Asignatura: Intervención en Crisis **Unidad:** 1 - Fundamentos y Primera Instancia **Nivel:** Pregrado Psicología

I. Contexto Previo (Funcionamiento Pre-Crisis)

Mariana es una arquitecta de 32 años, reconocida en su entorno laboral por ser meticulosa, organizada y altamente racional. Se describe a sí misma como una persona "con los pies en la tierra". Lleva 5 años de matrimonio con Roberto, con quien tiene un hijo de 2 años, Lucas. Su estructura de vida es rígida pero funcional: horarios estrictos, finanzas controladas y una red de apoyo social limitada a su familia nuclear y dos amigas cercanas. No presenta antecedentes psiquiátricos, aunque menciona que en su adolescencia tuvo episodios leves de ansiedad ante exámenes, que controlaba estudiando excesivamente. Su estilo de afrontamiento habitual ante el estrés es la acción y la resolución lógica de problemas.

II. El Suceso Precipitante

El sábado pasado, a las 10:00 PM, Mariana conducía de regreso a casa tras una cena familiar. Llovía torrencialmente. Roberto iba de copiloto y el bebé en la silla trasera. En una intersección, un vehículo se saltó el semáforo en rojo e impactó violentamente el lado del copiloto.

El impacto fue devastador. Mariana sufrió contusiones leves y un esguince cervical. El bebé, protegido por la silla de seguridad, salió ileso pero en estado de shock por el ruido. Roberto falleció instantáneamente debido al trauma craneoencefálico. Mariana estuvo consciente todo el tiempo, intentando despertar a su esposo mientras escuchaba el llanto de su hijo, hasta que llegaron los paramédicos 15 minutos después.

III. Estado de Crisis (Descripción Fenomenológica)

Las primeras 48 horas: Mariana fue trasladada al hospital. Al recibir la confirmación de la muerte de Roberto, entró en un estado de **embotamiento afectivo** (shock). No lloró. Se limitó a asentir y preguntar por trámites burocráticos con una voz monótona y mecánica. Rechazó el ofrecimiento de sedantes.

Estado actual (72 horas después - Momento de la Intervención): La familia de Mariana ha solicitado una visita domiciliar de un psicólogo de emergencias (usted) porque "Mariana no está actuando normal". Al llegar a la casa, se encuentra el siguiente panorama, evaluado bajo el perfil CASIC:

1. **Conductual:** Mariana no ha dormido en tres días. Camina incesantemente por la sala de estar frotándose las manos. No ha comido nada sólido, solo acepta sorbos de agua si se le insiste. Se niega a entrar a la habitación que compartía con su esposo y ha pedido que se lleven al niño a casa de los abuelos porque "no soporta escucharlo llorar".
2. **Afectiva:** Cuando usted intenta establecer contacto, el embotamiento inicial se rompe y da paso a una **inundación emocional**. Mariana experimenta oleadas de

culpa intensa. Repite frases como: "Debí haber frenado antes", "Yo lo maté", "Soy una inútil". Hay picos de irritabilidad extrema cuando su madre intenta consolarla, seguidos de llanto silencioso y profundo. Manifiesta un miedo paralizante a volver a subirse a un auto.

3. **Somática:** Presenta temblores visibles en las extremidades superiores. Refiere una sensación de "nudo en el pecho" que le impide respirar (disnea psicógena), taquicardia esporádica y náuseas constantes. Se observa palidez y ojeras marcadas.
4. **Interpersonal:** Se ha aislado en la sala. Ha apagado su celular y se niega a recibir a las amigas que han venido a dar el pésame. Siente que "nadie puede entenderla" y percibe la presencia de otros como una intrusión agresiva. Ha delegado el cuidado total de Lucas a su madre, mostrando una desconexión temporal del vínculo materno, lo cual refuerza su sentimiento de culpa ("soy mala madre, aparte de viuda").
5. **Cognoscitiva:** Su pensamiento es confuso y cíclico (rumiación). Tiene flashbacks intrusivos del momento exacto del impacto (el sonido del metal, la cara de su esposo). Presenta visión de túnel: solo puede enfocarse en el accidente y en la idea de que su vida "se terminó para siempre". Expresa ideas de desesperanza: "No voy a ser capaz de criar a Lucas sola", "Todo lo que construimos se rompió".

IV. Evaluación de Riesgo

Durante la entrevista de Primeros Auxilios Psicológicos, usted indaga sobre la mortalidad. Mariana confiesa: *"Anoche, cuando todos dormían, pensé que sería más fácil si yo también me hubiera ido con él... miré las pastillas para dormir de mi mamá, pero me dio miedo que Lucas se despertara y me necesitara"*.

No hay un plan estructurado inmediato, pero sí una ideación pasiva de muerte motivada por la culpa y la percepción de incapacidad para enfrentar el futuro (Peligro). Sin embargo, el pensamiento sobre su hijo actúa como un anclaje a la vida (Factor protector).

V. Cierre de la Primera Instancia

La intervención se centra en la contención, la validación de la culpa como parte del duelo traumático (no como un hecho real) y la satisfacción de necesidades básicas (dormir y comer). Se establece un plan de acción corto: su madre se quedará con ella, se acuerda una cita médica para manejo del insomnio y se pacta una llamada de seguimiento en 24 horas. Mariana acepta, con reticencia, que necesita ayuda para sobrevivir a esto por su hijo.